UE B1.3 S1 · 27 OCTOBRE 2026

FIÈVRE AU RETOUR DE VOYAGE ET PALUDISME

QCM — questions et corrigés argumentés

CONSIGNE

Pour chaque question, cochez les bonnes réponses parmi A à E. Il peut y avoir **une, deux ou trois bonnes réponses**. Toutes les corrections sont regroupées après les questions.

40 questions · 8 thèmes · 3 niveaux de difficulté

Les propositions portent sur les notions du cours. Les détails de prescription et les protocoles doivent toujours être appliqués selon les références de service.

Retour de voyage

FACILE

Q01 · Au retour d'un pays tropical, quelles causes doivent rester envisagées ?

- ☐ **A.** Une infection respiratoire courante.
- ☐ **B.** Une infection urinaire.
- ☐ **C.** Uniquement une parasitose tropicale.
- ☐ **D.** Une maladie tropicale selon l'exposition.
- ☐ **E.** Aucune infection si le séjour a été court.

FACILE

Q02 · Quelles informations sont indispensables dans l'anamnèse du voyage ?

- ☐ **A.** Pays et régions traversés.
- ☐ **B.** Dates de séjour et de début des signes.
- ☐ **C.** Uniquement le numéro de vol.
- ☐ **D.** Activités et expositions pendant le séjour.
- ☐ **E.** Le nom du fournisseur de billets.

MOYEN

Q03 · Le patient est fébrile après un voyage. Quelles propositions respectent la démarche présentée ?

- ☐ **A.** Chercher d'abord les signes de gravité.
- ☐ **B.** Repérer les points d'appel cliniques.
- ☐ **C.** Écarter automatiquement la grippe car il est allé en Afrique.
- ☐ **D.** Raisonner sur les expositions.
- ☐ **E.** Demander les examens sans tenir compte des signes.

MOYEN

Q04 · Quels événements du voyage peuvent orienter le diagnostic ?

- ☐ **A.** Baignade en eau douce.
- ☐ **B.** Piqûres de moustiques.
- ☐ **C.** Consommation d'eau non sécurisée.
- ☐ **D.** Couleur de la valise.
- ☐ **E.** Marque de l'appareil photo.

DIFFICILE

Q05 · À propos des fièvres restant sans diagnostic dans certaines séries, quelles affirmations sont prudentes ?

- ☐ **A.** Il existe des fièvres dont l'étiologie n'est pas identifiée.
- ☐ **B.** Le chiffre de la série garantit que tout patient guérit seul.
- ☐ **C.** Un résultat négatif ne dispense pas de revoir la gravité.
- ☐ **D.** Il faut toujours réaliser un panel illimité.
- ☐ **E.** Le taux observé n'est pas une règle individuelle.

Chronologie et signes

FACILE

Q06 · Concernant les dates de voyage, quelles affirmations sont exactes ?

- ☐ **A.** La date de retour aide à situer la dernière exposition possible.
- ☐ **B.** La date de début des symptômes est utile.
- ☐ **C.** L'incubation remplace l'examen clinique.
- ☐ **D.** Les périodes d'incubation peuvent se chevaucher.
- ☐ **E.** Tous les pathogènes ont 7 jours d'incubation.

MOYEN

Q07 · Quelles affections sont citées pour des incubations plutôt courtes ?

- ☐ **A.** Certaines arboviroses.
- ☐ **B.** Diarrhée du voyageur.
- ☐ **C.** Toutes les hépatites chroniques.
- ☐ **D.** Toute infection à tropisme hépatique.
- ☐ **E.** Toujours une infection à P. ovale dormante.

MOYEN

Q08 · Quels éléments suggèrent une fièvre avec foyer ?

- ☐ **A.** Brûlures urinaires et douleur lombaire.
- ☐ **B.** Crépitants respiratoires et toux.
- ☐ **C.** Lésion cutanée inflammatoire localisée.
- ☐ **D.** Absence de tout symptôme associé.
- ☐ **E.** Exposition au soleil sans symptôme.

DIFFICILE

Q09 · Un patient revenu d'une zone palustre n'a plus de fièvre au moment du triage. Quelles propositions sont justes ?

- ☐ **A.** Le paludisme reste possible.
- ☐ **B.** Une sensation fébrile ou des frissons sont à recueillir.
- ☐ **C.** La température normale exclut une parasitose sanguine.
- ☐ **D.** La notion de prophylaxie n'est pas suffisante pour exclure le risque.
- ☐ **E.** Le diagnostic doit attendre l'apparition d'une fièvre tierce.

MOYEN

Q10 · Face à un ictère fébrile après un voyage, que faut-il considérer ?

- ☐ **A.** Le paludisme.
- ☐ **B.** Certaines hépatites.
- ☐ **C.** La leptospirose selon exposition.
- ☐ **D.** Une cause nécessairement unique et évidente.
- ☐ **E.** L'absence de tout besoin d'examen.

Infectiologie et BMR

FACILE

Q11 · Que désigne une BMR ?

- ☐ **A.** Une bactérie multirésistante.
- ☐ **B.** Un portage possible sans infection clinique.
- ☐ **C.** Une infection virale du voyageur.
- ☐ **D.** Un parasite des hématies.
- ☐ **E.** Un marqueur de glycémie.

MOYEN

Q12 · Devant des soins ou une hospitalisation à l'étranger, quels réflexes conviennent ?

- ☐ **A.** Recueillir le contexte des soins.
- ☐ **B.** Informer l'équipe de soins.
- ☐ **C.** Appliquer les mesures prévues par le protocole d'hygiène.
- ☐ **D.** Isoler automatiquement toute personne ayant quitté la France.
- ☐ **E.** Considérer que le paludisme se transmet par contact cutané ordinaire.

FACILE

Q13 · Pour les hémocultures prescrites, quelles propositions sont correctes ?

- ☐ **A.** Respecter l'asepsie de prélèvement.
- ☐ **B.** Respecter le volume de remplissage prévu.
- ☐ **C.** Négliger l'étiquetage.
- ☐ **D.** Identifier correctement les prélèvements.
- ☐ **E.** Mettre moins de sang systématiquement pour éviter le risque.

DIFFICILE

Q14 · Un paludisme confirmé impose-t-il à lui seul un isolement contact ?

- ☐ **A.** Non, pas pour la transmission palustre habituelle.
- ☐ **B.** Oui, car les globules rouges se transmettent par poignée de main.
- ☐ **C.** Des précautions peuvent être motivées par un autre risque associé au voyage.
- ☐ **D.** Le protocole d'hygiène local reste pertinent.
- ☐ **E.** Tous les cas nécessitent un isolement aérien.

MOYEN

Q15 · Au retour de voyage, quelles informations préventives rechercher ?

- ☐ **A.** Vaccinations réalisées.
- ☐ **B.** Chimioprophylaxie antipaludique et observance.
- ☐ **C.** Protections contre les piqûres.
- ☐ **D.** Un certificat de vaccin comme garantie absolue de protection.
- ☐ **E.** La marque du bagage.

Agent et cycle

FACILE

Q16 · Quel agent est responsable du paludisme ?

- ☐ **A.** Un parasite du genre Plasmodium.
- ☐ **B.** Un protozoaire.
- ☐ **C.** Une bactérie du genre Streptococcus.
- ☐ **D.** Un champignon microscopique.
- ☐ **E.** Un prion.

FACILE

Q17 · Quel organisme transmet habituellement le paludisme ?

- ☐ **A.** La femelle anophèle infectée.
- ☐ **B.** Le moustique vecteur.
- ☐ **C.** Un contact social ordinaire sans vecteur.
- ☐ **D.** Le rhinovirus.
- ☐ **E.** La mouche domestique dans tous les cas.

MOYEN

Q18 · Quelles étapes de Plasmodium se déroulent chez l'être humain ?

- ☐ **A.** Passage initial par le foie.
- ☐ **B.** Invasion des globules rouges.
- ☐ **C.** Multiplication parasitaire sanguine.
- ☐ **D.** Reproduction sexuée principale dans le moustique.
- ☐ **E.** Transmission du parasite par parole.

MOYEN

Q19 · Au sujet des formes parasitaires, quelles affirmations sont exactes ?

- ☐ **A.** Le sporozoïte est inoculé par le moustique.
- ☐ **B.** Le mérozoïte envahit les globules rouges.
- ☐ **C.** Le gamétocyte participe à la transmission vers le moustique.
- ☐ **D.** Le gamétocyte est un globule blanc.
- ☐ **E.** Le schizonte n'intervient jamais dans le cycle.

DIFFICILE

Q20 · Concernant P. vivax et P. ovale, qu'est-il juste de retenir ?

- ☐ **A.** Des formes hépatiques dormantes peuvent exister.
- ☐ **B.** Des rechutes tardives sont possibles.
- ☐ **C.** Chaque nouvel accès résulte forcément d'une nouvelle piqûre.
- ☐ **D.** Le mécanisme doit être distingué de la simple recrudescence sanguine.
- ☐ **E.** Ces espèces sont des bactéries.

Physiopathologie

FACILE

Q21 · Qu'est-ce que la cytoadhérence dans le paludisme à P. falciparum ?

- ☐ **A.** L'adhésion de globules rouges parasités à des microvaisseaux.
- ☐ **B.** Un phénomène impliquant des protéines exprimées à la surface des hématies infectées.
- ☐ **C.** Le passage de bactéries dans les urines.
- ☐ **D.** Une technique de frottis sanguin.
- ☐ **E.** Une réaction allergique universelle au médicament.

MOYEN

Q22 · Quelles manifestations peuvent résulter de la séquestration parasitaire ?

- ☐ **A.** Altération de la microcirculation.
- ☐ **B.** Défaillance d'organe.
- ☐ **C.** Atteinte neurologique grave.
- ☐ **D.** Disparition garantie de la parasitémie.
- ☐ **E.** Impossibilité d'une défaillance respiratoire.

DIFFICILE

Q23 · Que décrit le terme rosetting ?

- ☐ **A.** Une hématie parasitée associée à des hématies non parasitées.
- ☐ **B.** Un phénomène d'agrégation distinct de la seule multiplication.
- ☐ **C.** Une technique de vaccination.
- ☐ **D.** Un mécanisme contribuant à l'obstruction microvasculaire.
- ☐ **E.** La forme infectante injectée par le moustique.

MOYEN

Q24 · Pourquoi l'évaluation doit-elle être rapide ?

- ☐ **A.** L'aggravation peut survenir sans tableau très spécifique initialement.
- ☐ **B.** La cytoadhérence peut contribuer à des atteintes d'organes.
- ☐ **C.** Un accès palustre grave est possible.
- ☐ **D.** On peut toujours prévoir précisément l'heure du coma.
- ☐ **E.** Une fièvre tierce doit impérativement précéder tout signe grave.

DIFFICILE

Q25 · Quelles affirmations sur le cycle sont compatibles avec le cours ?

- ☐ **A.** Le cycle érythrocytaire de P. falciparum est présenté autour de 48 h.
- ☐ **B.** La rupture des hématies libère de nouveaux mérozoïtes.
- ☐ **C.** Tous les globules rouges parasités deviennent immédiatement séquestrés.
- ☐ **D.** La phase hépatique précède la multiplication sanguine.
- ☐ **E.** Le moustique est l'hôte du cycle asexué humain.

Diagnostic et gravité

FACILE

Q26 · Quels signes ou résultats doivent alerter sur la gravité ?

- ☐ **A.** Trouble de conscience.
- ☐ **B.** Détresse respiratoire.
- ☐ **C.** Hypoglycémie significative.
- ☐ **D.** Simple absence de fièvre au triage prise isolément.
- ☐ **E.** Couleur du bagage.

FACILE

Q27 · Que permet l'examen du frottis sanguin ?

- ☐ **A.** Voir des parasites dans des globules rouges.
- ☐ **B.** Contribuer à identifier une espèce parasitaire.
- ☐ **C.** Estimer une parasitémie selon lecture.
- ☐ **D.** Remplacer toujours toute autre technique.
- ☐ **E.** Mettre en évidence toutes les infections tropicales.

MOYEN

Q28 · À propos des TDR de paludisme, quelles propositions sont prudentes ?

- ☐ **A.** Ils peuvent détecter certains antigènes parasitaires.
- ☐ **B.** Ils rendent service pour un diagnostic rapide.
- ☐ **C.** Leur performance dépend du test et du contexte.
- ☐ **D.** Ils rendent toujours superflue la microscopie.
- ☐ **E.** Ils sont identiques à une hémoculture.

MOYEN

Q29 · Concernant PCR et LAMP, quelles affirmations sont justes ?

- ☐ **A.** Ce sont des méthodes moléculaires.
- ☐ **B.** Elles ne correspondent pas à la même technique.
- ☐ **C.** Elles peuvent être sensibles selon les systèmes de laboratoire.
- ☐ **D.** LAMP est une simple coloration du frottis.
- ☐ **E.** La biologie moléculaire rend inutile tout examen clinique.

DIFFICILE

Q30 · Un patient avec parasitémie confirmée présente des convulsions. Quelles affirmations sont compatibles ?

- ☐ **A.** C'est un signe possible d'accès grave.
- ☐ **B.** L'orientation et la surveillance deviennent urgentes.
- ☐ **C.** Une prise en charge adaptée des défaillances est nécessaire.
- ☐ **D.** Le patient est nécessairement en accès simple.
- ☐ **E.** Le traitement doit attendre trois accès fébriles rythmiques.

Traitements

FACILE

Q31 · Quelles propositions respectent la distinction accès simple / grave présentée ?

- ☐ **A.** Accès simple : des associations orales peuvent être utilisées.
- ☐ **B.** Accès grave : artésunate IV.
- ☐ **C.** Accès grave : la voie orale seule est toujours adaptée.
- ☐ **D.** Le lieu de soins dépend de l'état clinique.
- ☐ **E.** La classification n'a pas de conséquence thérapeutique.

MOYEN

Q32 · Quels couples sont cités parmi les antipaludiques oraux ?

- ☐ **A.** Artéméther-luméfantrine.
- ☐ **B.** Arténimol-pipéraquine.
- ☐ **C.** Amoxicilline-clavulanate.
- ☐ **D.** Atovaquone-proguanil.
- ☐ **E.** Ibuprofène-paracétamol.

MOYEN

Q33 · Après artésunate IV pour accès grave, que faut-il retenir ?

- ☐ **A.** Le relais oral complet est prévu dès que possible selon protocole.
- ☐ **B.** La seule amélioration clinique ne signifie pas traitement terminé.
- ☐ **C.** La surveillance continue selon les prescriptions.
- ☐ **D.** Le traitement s'arrête obligatoirement après une dose.
- ☐ **E.** Le patient peut reprendre une activité sans suivi.

DIFFICILE

Q34 · Sur les conditions de prise des antipaludiques oraux, quelles propositions sont exactes ?

- ☐ **A.** Elles varient d'une association à l'autre.
- ☐ **B.** Le médicament précis prescrit doit être vérifié.
- ☐ **C.** La prise avec repas est universelle pour toutes les molécules.
- ☐ **D.** Arténimol-pipéraquine est cité comme nécessitant une prise à jeun.
- ☐ **E.** La posologie peut être déduite du seul nom de la maladie.

DIFFICILE

Q35 · Quelle surveillance après artésunate IV est citée ?

- ☐ **A.** Recrudescence clinique/parasitologique.
- ☐ **B.** Anémie hémolytique retardée.
- ☐ **C.** Contrôles dans les semaines suivantes selon protocole.
- ☐ **D.** Aucune surveillance après sortie.
- ☐ **E.** Arrêt de tout contrôle si la fièvre disparaît.

Prévention et rôle IDE

FACILE

Q36 · Quelles mesures participent à la prévention du paludisme ?

- ☐ **A.** Protection contre les piqûres.
- ☐ **B.** Moustiquaire imprégnée selon contexte.
- ☐ **C.** Chimioprophylaxie prescrite selon le risque.
- ☐ **D.** Prise systématique d'antibiotiques pour tous les voyageurs.
- ☐ **E.** Isolement contact de toutes les personnes de retour.

MOYEN

Q37 · Comment raisonner sur une chimioprophylaxie ?

- ☐ **A.** Tenir compte de la destination précise.
- ☐ **B.** Tenir compte du terrain et des contre-indications.
- ☐ **C.** Vérifier la molécule et les dates des prises.
- ☐ **D.** Appliquer une durée post-retour identique à toutes les molécules.
- ☐ **E.** Conclure à un risque nul sous prophylaxie.

MOYEN

Q38 · Une personne ayant suivi une prophylaxie consulte pour malaise après un voyage en zone palustre. Que faire ?

- ☐ **A.** Signaler le séjour et la prévention prise.
- ☐ **B.** Conserver le paludisme parmi les hypothèses.
- ☐ **C.** Évaluer et signaler les signes de gravité.
- ☐ **D.** Écarter automatiquement le paludisme.
- ☐ **E.** Attendre le prochain voyage pour consulter.

MOYEN

Q39 · Dans la prise en charge IDE, quels objectifs sont pertinents ?

- ☐ **A.** Respecter la qualité du prélèvement sanguin.
- ☐ **B.** Surveiller conscience et état hémodynamique selon l'état.
- ☐ **C.** S'assurer de la compréhension du relais oral prescrit.
- ☐ **D.** Modifier seul le traitement antipaludique si les symptômes changent.
- ☐ **E.** Déclarer sans contrôle toute température normale comme guérison.

DIFFICILE

Q40 · Quelles erreurs de raisonnement faut-il éviter ?

- ☐ **A.** Confondre portage de BMR et infection palustre.
- ☐ **B.** Traiter toutes les régions tropicales comme un risque identique.
- ☐ **C.** Faire dépendre le diagnostic uniquement de la présence de fièvre lors de la consultation.
- ☐ **D.** Signaler les dates et détails du voyage.
- ☐ **E.** Distinguer prévention anti-vectorielle et médicamenteuse.

Corrigés argumentés

Les réponses sont données uniquement ici, dans l'ordre des questions. Pour chaque item, distinguer ce qui est exact des propositions à écarter.

Retour de voyage

Q01 — Réponses : A, B, D. Les causes cosmopolites restent possibles ; les causes tropicales sont évaluées selon l'exposition.

Q02 — Réponses : A, B, D. Les lieux, dates et comportements aident à établir les risques et les délais d'incubation.

Q03 — Réponses : A, B, D. La démarche est systématique et orientée : gravité, clinique et exposition.

Q04 — Réponses : A, B, C. Les voies de transmission dépendent des comportements et des expositions réelles.

Q05 — Réponses : A, C, E. Une proportion non élucidée est décrite dans des études ; elle ne doit jamais retarder le diagnostic urgent ni devenir une assurance clinique.

Chronologie et signes

Q06 — Réponses : A, B, D. La chronologie oriente mais ne suffit pas à exclure une étiologie.

Q07 — Réponses : A, B. La diarrhée du voyageur et les arboviroses peuvent se présenter précocement après l'exposition. Les autres propositions sont trop générales ou relèvent de délais différents.

Q08 — Réponses : A, B, C. Les signes localisés orientent les examens, tout en gardant à l'esprit les risques d'importation.

Q09 — Réponses : A, B, D. La fièvre est fluctuante et la maladie peut être peu spécifique.

Q10 — Réponses : A, B, C. L'ictère est un signe d'appel partagé par plusieurs infections.

Infectiologie et BMR

Q11 — Réponses : A, B. Le portage ou l'infection à BMR concerne les bactéries résistantes, pas le paludisme.

Q12 — Réponses : A, B, C. Le risque BMR nécessite une évaluation et des précautions selon les procédures, sans généralisation au seul voyage.

Q13 — Réponses : A, B, D. L'enseignant insiste sur la qualité de prélèvement, notamment le remplissage.

Q14 — Réponses : A, C, D. La transmission habituelle implique un moustique vecteur ; les autres risques se jugent séparément.

Q15 — Réponses : A, B, C. Les vaccinations et mesures de prévention nuancent le risque sans l'annuler.

Agent et cycle

Q16 — Réponses : A, B. Le paludisme est dû à des parasites protozoaires du genre Plasmodium : il ne s'agit ni d'une bactérie, ni d'un champignon, ni d'un prion.

Q17 — Réponses : A, B. La forme infectante est inoculée par l'anophèle femelle infectée.

Q18 — Réponses : A, B, C. Les phases hépatiques et sanguines se déroulent chez l'humain ; la reproduction sexuée chez le moustique.

Q19 — Réponses : A, B, C. Ces trois formes interviennent à différentes étapes du cycle décrit en séance.

Q20 — Réponses : A, B, D. Les hypnozoïtes hépatiques expliquent des rechutes tardives pour ces espèces.

Physiopathologie

Q21 — Réponses : A, B. La cytoadhérence participe à la séquestration microvasculaire.

Q22 — Réponses : A, B, C. Le processus contribue aux complications cérébrales et multiviscérales.

Q23 — Réponses : A, B, D. Le rosetting est un phénomène d'adhésion cellulaire associé à la physiopathologie grave.

Q24 — Réponses : A, B, C. L'intervenant insiste sur l'imprévisibilité individuelle de certaines décompensations.

Q25 — Réponses : A, B, D. Le cours distingue hépatique/sanguin et explique la maturation avant séquestration.

Diagnostic et gravité

Q26 — Réponses : A, B, C. Les défaillances d'organes et anomalies métaboliques font partie des signes cités.

Q27 — Réponses : A, B, C. Le frottis est un examen microscopique parasitologique du sang.

Q28 — Réponses : A, B, C. Les TDR complètent l'arsenal ; un protocole encadre le diagnostic.

Q29 — Réponses : A, B, C. PCR et LAMP recherchent du matériel génétique par des méthodes différentes.

Q30 — Réponses : A, B, C. Les signes neurologiques imposent une réaction immédiate dans ce contexte.

Traitements

Q31 — Réponses : A, B, D. La gravité oriente voie et niveau de surveillance.

Q32 — Réponses : A, B, D. Trois associations antipaludiques sont évoquées ; le choix est médical.

Q33 — Réponses : A, B, C. Le relais oral est une priorité explicitement soulignée à plusieurs reprises.

Q34 — Réponses : A, B, D. Le cours attire l'attention sur les consignes alimentaires spécifiques ; pas de généralisation.

Q35 — Réponses : A, B, C. Le suivi est présenté jusqu'à environ J28, avec vigilance sur l'hémolyse tardive.

Prévention et rôle IDE

Q36 — Réponses : A, B, C. Le cours insiste sur prévention anti-vectorielle et médicamenteuse individualisée.

Q37 — Réponses : A, B, C. L'indication et la durée dépendent des caractéristiques du séjour et du médicament.

Q38 — Réponses : A, B, C. La prévention réduit le risque mais n'exclut pas une infection.

Q39 — Réponses : A, B, C. Préparation, surveillance, transmissions et éducation sont centrales, sans substitution à la prescription.

Q40 — Réponses : A, B, C. Les trois premières propositions sont des pièges ; une exposition s'analyse individuellement.